

TEMA 2.13 • TRAUMATOLOGÍA

Traumatología Infantil

PERFIL EUNACOM 1.08.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Este artículo aborda las patologías más frecuentes de la reumatología clínica y de urgencias: la **Artrosis** (enfermedad degenerativa) y el enfrentamiento de la **Monartritis Aguda**, que incluye las artritis por cristales y la artritis séptica.

Artrosis (Osteoartritis)

La artrosis es una enfermedad degenerativa caracterizada por la destrucción progresiva del **cartílago articular**. Es fundamental entender que el cartílago no tiene capacidad de regeneración.

Etiología

- **Primaria:** Causa degenerativa idiopática con un fuerte componente genético. - **Secundaria:** Resulta de un daño previo en la articulación, como: - Luxaciones crónicas. - Fracturas con rasgo intraarticular. - **Artritis Reumatoide.** - Secuelas de **Artritis Séptica**.

Clínica

El síntoma cardinal es el **dolor articular**. - El dolor suele ser de tipo mecánico (empeora con el uso, mejora con el reposo). - Puede evolucionar a la **anquilosis** (rigidez total de la articulación). - Puede presentar derrame articular de tipo **no inflamatorio**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Para diagnosticar artrosis, el paciente **debe tener dolor**. Una radiografía alterada con signos de daño articular en un paciente asintomático **no** se considera artrosis clínicamente relevante.

Diagnóstico Radiológico

Se basa en la clínica apoyada por la radiografía. Los cuatro hallazgos clásicos son:

TABLA 2.13.1: HALLAZGO RADIOGRÁFICO VS DESCRIPCIÓN

HALLAZGO RADIOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
Disminución del espacio articular	El cartílago se desgasta y los huesos se acercan.
Osteofitos	Crecimientos óseos marginales ("cachitos").
Esclerosis subcondral	El hueso cercano a la articulación se ve más blanco (radiopaco).
Geodas	Quistes subcondrales o lesiones en "sacabocado" bajo la superficie.

Tratamiento Escalonado

El objetivo principal es la analgesia y la funcionalidad.

- **Primera Línea:** Paracetamol (1g cada 8 horas) + Ejercicio de fortalecimiento (especialmente de cuádriceps para artrosis de rodilla).
- **Segunda Línea:** AINEs.
 - Inhibidores COX-1 (ej. Ibuprofeno) deben asociarse a Omeprazol para protección gástrica.
 - Inhibidores COX-2 (ej. Celecoxib) tienen menor riesgo de úlcera.
- **Tercera Línea:** Opiáceos débiles, principalmente **Tramadol**.
- **Cuarta Línea:** Corticoides intraarticulares (infiltraciones).
- **Quinta Línea (Quirúrgica):** Prótesis articular (reemplazo) o artrodesis (fijación, común en interfalángicas).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si el paciente tiene **Insuficiencia Renal Crónica o Úlcera Gastroduodenal**, los AINEs están contraindicados. En ese caso, el tratamiento salta directamente del Paracetamol al Tramadol.

Enfrentamiento de la Monartritis Aguda

Ante una articulación inflamada (dolor, aumento de volumen, eritema y calor), la conducta mandatoria es realizar una **artrocentesis** (punción articular) para analizar el líquido sinovial.

Análisis del Líquido Sinovial

TABLA 2.13.2: TIPO DE LÍQUIDO VS CÉLULAS (LEUCOCITOS/MM³)

TIPO DE LÍQUIDO	CÉLULAS (LEUCOCITOS/MM ³)	ASPECTO Y FILANCIA	SOSPECHA CLÍNICA
No Inflamatorio	< 1.000	Transparente, filante (clara de huevo)	Artrosis
Inflamatorio	> 1.000	Turbio, baja filancia (café con leche)	Artritis por cristales, Artritis Reumatoide
Séptico	> 50.000 - 100.000	Purulento	Artritis Séptica

Artritis por Cristales

1. Gota

Causada por cristales de **urato monosódico**. - **Clínica:** Monartritis aguda recidivante. La localización más clásica es la primera metatarsofalángica (**Podagra**). - **Cristales:** Presentan **elongación negativa** (se ven amarillentos/anaranjados bajo luz polarizada).

2. Condrocálcinosis (Pseudogota)

Causada por cristales de **pirofosfato de calcio**. - **Clínica:** Afecta frecuentemente la **rodilla**. - **Cristales:** Presentan **elongación positiva** (brillan de color azulado).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La **Podagra** es la única monartritis aguda que suele diagnosticarse clínicamente sin necesidad de punción, a menos que se sospeche infección.

Tratamiento de la Gota

- **Crisis Aguda:** AINEs endovenosos o **Colchicina** (ojo con la diarrea como efecto adverso). - **Manejo Crónico (Profilaxis):** - Indicado si el paciente tiene **2 o más crisis al año**. - Fármacos: **Alopurinol** (inhibidor de la xantina oxidasa) o Probenecid (uricosúrico). - **Metas de Ácido Úrico:** < 6 mg/dL en mujeres y < 7 mg/dL en hombres.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Jamás inicie ni suspenda el Alopurinol durante una crisis aguda, ya que los cambios bruscos en los niveles de ácido úrico pueden empeorar o prolongar la inflamación.

Artritis Séptica

Es una urgencia médica por el riesgo de destrucción articular rápida y sepsis.

Diagnóstico Etiológico y Antibióticos

Si el Gram del líquido sinovial muestra: - **Cocáceas Gram (+):** Sospecha de *Staphylococcus aureus*. Tratamiento: **Cloxacilina** o Cefazolina EV. - **Diplococos Gram (-):** Sospecha de *Neisseria gonorrhoeae* (Gonococo). Tratamiento: **Ceftriaxona** EV.

Pilares del Tratamiento

1. **Antibioticoterapia endovenosa** según sospecha/cultivo. 2. **Drenaje quirúrgico** de la articulación (idealmente por artroscopia) para eliminar el material purulento.

NOTA CLÍNICA

Si en el líquido sinovial coexisten cristales y bacterias, el cuadro se maneja siempre como una **Artritis Séptica**, ya que es la condición más grave.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Recién nacida de dos días de vida, sexo femenino, parto en presentación podálica. En el examen físico se detecta que al flexionar y abducir la cadera se escucha un clic y la cadera luxada logra reposicionarse en el acetábulo. ¿Cuál de los siguientes describe correctamente este hallazgo?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Traumatología Infantil. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Ahora, la displasia de cadera se enfrenta con un examen de screening que se puede hacer con la
- examen de screening que se elige aquí en Chile, ya. Ahora, si me dicen un niño de tres meses viene
- a los dos meses se elige en cambio la ecografía de caderas como el examen de elección, ya. Ahora,
- el tratamiento de la displasia de caderas, la verdad es que depende de la edad y este es el
- concepto a menor edad, mayor éxito, así que lo importante es de notificarlo lo antes posible,
- para que son de bien, ya. Ahora, una opción es las correas de pablic, que es el tratamiento
- yugo, ya. Finalmente está el tratamiento quirúrgico, que es la famosa reducción cruenta o reducción

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRAUMATOLOGIA INFANTIL)

PREGUNTA 1

Recién nacida de dos días de vida, sexo femenino, parto en presentación podálica. En el examen físico se detecta que al flexionar y abducir la cadera se escucha un clic y la cadera luxada logra reposicionarse en el acetábulo. ¿Cuál de los siguientes describe correctamente este hallazgo?

- A) Signo de Barlow positivo: la cadera encajada se luxa al aplicar presión
- B) Signo de Ortolani positivo: la cadera luxada se reduce al abducir
- C) Arco de Shenton discontinuo visible en la radiografía AP de pelvis
- D) Pie bot o pie zambo bilateral por artrogriposis neonatal
- E) Epifisiólisis de la cabeza femoral por obesidad en el adolescente

PREGUNTA 2

Niño de siete años, previamente sano, de talla baja para su edad y que practica fútbol cuatro veces por semana. Consulta por dolor en la ingle derecha y cojera de dos semanas de evolución. La radiografía AP de pelvis muestra aplanamiento y aumento de densidad de la cabeza femoral derecha en comparación con la izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Sinovitis transitoria de cadera
- B) Artritis séptica de cadera derecha
- C) Epifisiólisis de la cabeza femoral derecha
- D) Enfermedad de Perthes de cadera derecha
- E) Displasia del desarrollo de cadera con luxación tardía

PREGUNTA 3

Adolescente de trece años, obeso, que consulta por dolor en la cadera izquierda y cojera progresiva de tres semanas. La radiografía AP de pelvis muestra desplazamiento posterior e inferior de la epífisis femoral izquierda, con imagen descrita como signo del helado caído. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

- A) Reposo absoluto y antiinflamatorios no esteroideos por cuatro semanas
- B) Correas de Pavlik para reducción ortopédica gradual
- C) Observación y quinesioterapia de fortalecimiento muscular
- D) Yeso pelvipedio con yugo por seis semanas
- E) Reducción quirúrgica y fijación con tornillo de la epífisis femoral

RESUMEN: TRAUMATOLOGIA INFANTIL

Hola, hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de un tema que es traumatología infantil, que se pregunta en pediatría y se pregunta en traumatología, así que es pregunta segura por si acaso. Ahora, los temas son bastante, displasia de cadera, escoliosis, el pie bot o pie sambos, el pie plano, la sinovitis transitoria, la enfermedad de Perthes, la epifisiolisis de la cadera es afemoral, ya van a ser todos los temas que vamos a ver que son los temas que habitualmente se preguntan. Empecemos con displasia de cadera, acuérdense que su clínica habitualmente es totalmente asintomático, pero al examinar aún recién nacido, aún lactante, yo puedo ver los signos de Ortolani y signos de Barlow. Ahora, ¿qué es el signo de Ortolani que yo puedo reposicionar o reducir la cadera que está básicamente luxada? O sea, la cadera viene luxada y yo puedo encajarla, ya, en cambio del signo de Barlow es lo contrario, la cadera está encajada y yo puedo luxarla, ya, así que el de Ortolani es, yo la reduzco, la reposiciono, la de Barlow yo la luxa en cambio, ya. Ahora, el riesgo que tiene la displasia de cadera es que a largo plazo evoluciona con artrosis, cierto, con dolor, con claudicación, con afectación para toda la vida, así que es algo que hay que diagnosticar temprano y manejar a tiempo, ya. Ahora, los factores de riesgo son toda la lista que está ahí, número uno sexo femenino, número dos que venga en presentación hipodálica, cierto, el oligoamnios, en sentido que eso igual hace que las c